



Universitair
Ziekenhuis
Brussel

Slaaplabo Volwassenen
02/477.60.68

Verslag Polysomnografie

Patient Data

Naam: **VAN DER AA**
Voornaam: **STEPHANE**
Geboortedatu: **1976-10-25**
ID: **A761025VA00L**
Lengte: **195 cm**
Gewicht: **95 kg**
BMI: **24,98 kg/m²**

Datum PSG 2014-06-03

Indicatie PSG : **Dyssomnie**
Huisarts: **Dr. Beke**
Verwijzende arts: **Dr. De Raedt**
Somnoloog : **Dr. S. De Weerd**
Scorer: **Birgitt**
Montage name: **PSG**

Slaap Stadia Tijd (min)

Stage 1	0:04:30	Movement	0:00:00
Stage 2	5:30:30	Wake	0:34:49
Stage 3	1:37:29	WASO	00:27:00
Stage 4	0:00:00	SE [%]	93,7
SWS	1:37:29	TST	8:35:00
REM	1:22:30	REM latency	00:59:30
Sleep Latency Stage 1	00:07:49		
Sleep Latency Stage 2	00:07:49		

Stadia Overgangen (Index)

89 (9,7)

Opname

	Start	Stop	Artefact	Duur
Opname tijd	2014-06-03 21:5	2014-06-04 07:0		9:09:59
Tijd In Bed	2014-06-03 21:52:10	2014-06-04 07:02:00	0:00:00	9:09:49

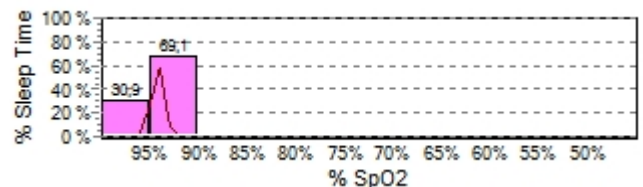
MAI

Aantal (Index) **164 (19,2)**

Respiratoire events		Aantal (Index)		REM	Non-REM	TST
Obstructief	2 (0,2)	Apnoea (Index)	0 (0)	3 (0,4)	3 (0,3)	
Mixed	0 (0)	Hypopnoea (Index)	26 (18,9)	80 (11,1)	106 (12,3)	
Centraal	1 (0,1)	AHI [/h]	18,9	11,5	12,7	
niet-geïd. A.	0 (0)	Flow Limitation (Index)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Totale A.	3 (0,3)	RERAs (Index)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Hypopnoea	106 (12,3)	Max. Apnoea Duur [s]	0	19	19	
A+H	109 (12,7)	Max. Hypopnoea	41	59	59	
Limitation	0 (0)	Gem. Apnoea Duur [s]	0	18,6	18,6	
RERAs	0 (0)	Gem. Hypopnoea Duur. [s]	28,2	27,1	27,4	
RDI	109 (12,7)	Artefact [min]	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	

Positie	Ruglig	Niet in Ruglig	Links	Rechts	Buiklig	Recht
Sleep Time Fraction [%]	28,2	71,8	39,5	32,2	0	0
Totale Events (Index)	65 (26,8)	44 (7,1)	13 (3,8)	31 (11,2)	0 (0)	0 (0)
Obstructief Apnoea (Index)	2 (0,8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Centraal Apnoea (Index)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Mixed Apnoea (Index)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Hypopnoea (Index)	62 (25,6)	44 (7,1)	13 (3,8)	31 (11,2)	0 (0)	0 (0)
Flow Limitation (Index)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
RERAs (Index)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

O2 Saturatie	Aantal (Index)	Tijd
Aantal Desaturaties (Index)	29 (3,4)	
Minimale SpO2 [%]	90	23:22:44
lBaseline O2 Saturatie	94	
Gem. SpO2 [%]	94	
Aantal desaturaties < 90 %	0	0 %
Aantal desaturaties < 80 %	0	0 %
SpO2 Tijd < 90 %	0 %	00:00:00
Grootste Desaturatie [%]	8	05:20:33
Gem. Desaturatie [%]	4,8	56,1 s
Langste Desaturatie [s]	161,5	23:06:57
Deepest Desaturation [%]	90	23:22:46
Totale desaturatieduur	0:27:06	5,3 %
Artefact [min]	0,1 (0,0%)	

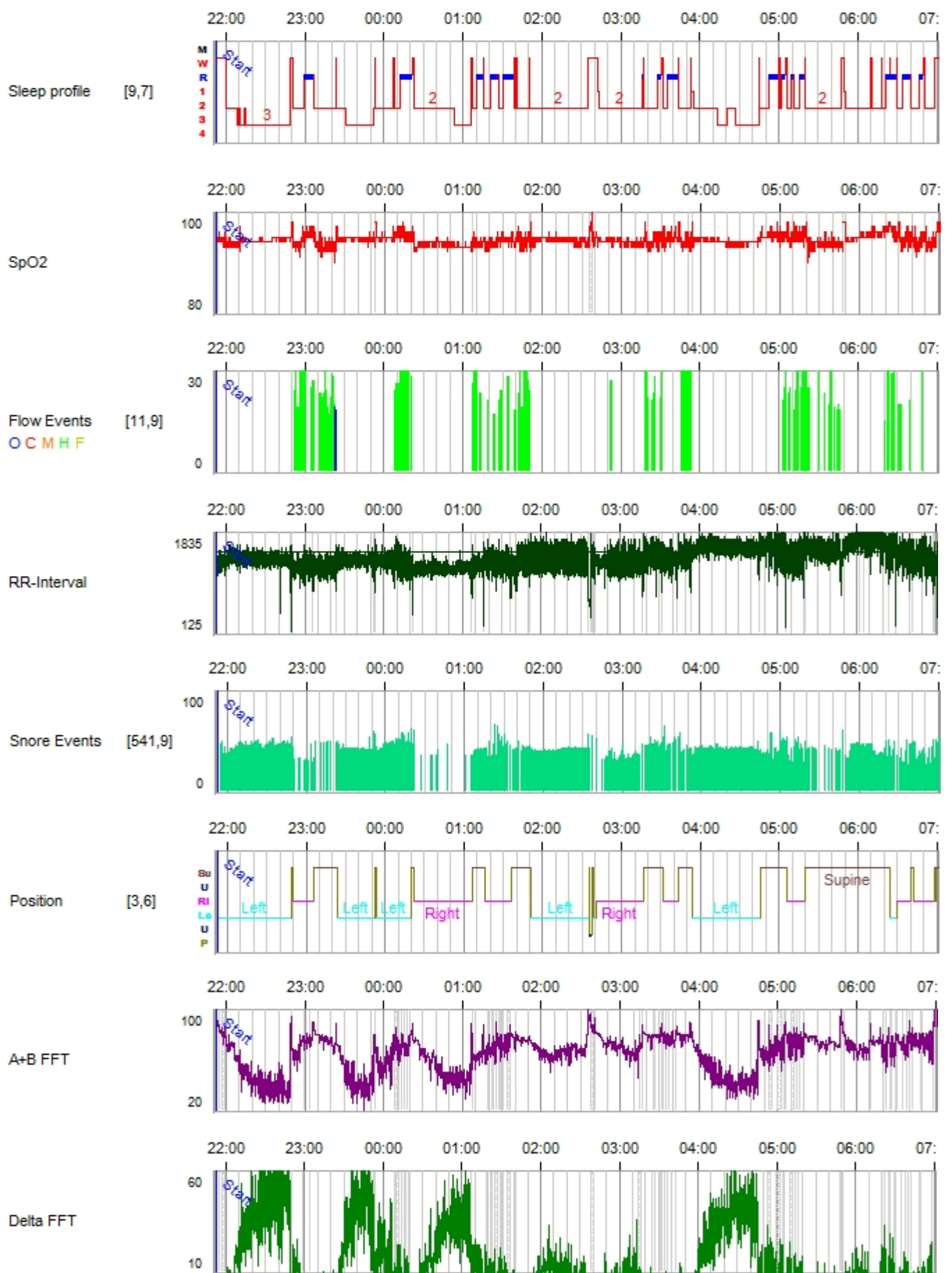


Periodic Leg Movement		
PLMs (Index)	159 (18,5)	
PLM A.	6 (0,7)	3,7

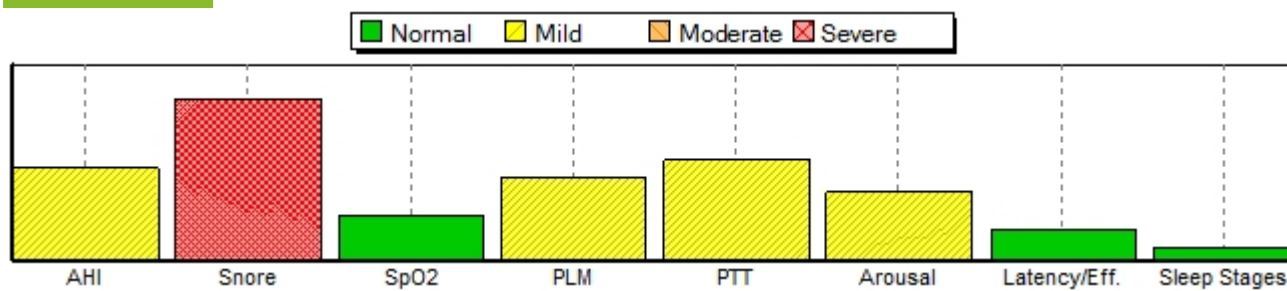
Cardiologische Events	Aantal (Index)	Tijd
Tachycardie (Index)	23 (2,7)	
Bradycardie (Index)	45 (5,2)	
Arrhythmia (Index)	3 (0,3)	
Maximum HR [bpm]	79	01:36:43
Minimum HR [bpm]	32	05:20:26
Gem. HR [bpm]	42	

REM Density [%]	7
-----------------	---

Slaap Stadia Distributie				
Stadia	Duur	(%) TIB	(%) TST	(%) SPT
Artefact	00:00:00	0	0	0
Wake	0:34:49	6,3	0	4,4
Stage 1	0:04:30	0,8	0,9	0,8
Stage 2	5:30:30	60,1	64,2	61,4
Stage 3	1:37:29	17,7	18,9	18,1
Stage 4	0:00:00	0	0	0
REM	1:22:30	15	16	15,3
Movement	0:00:00	0	0	0
SWS	1:37:29	17,7	18,9	18,1



Overzicht



Bespreking

Slaperigheidsschalen :

Epworth Sleepiness Scale (ESS) : 1 - 6 normaal, 7 - 9 gemiddeld, meer dan 10 afwijkend.

Stanford Slaperigheidsschaal (SSS) : 1 Actief , levenslustig , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 valt voortdurend in slaap .

Pittsburgh Slaapkwaliteitsindex (PSQI) : 0 = goede slaapkwaliteit , 21 = slechte slaapkwaliteit .

ESS = 2

SSS = 3

PSQI = 15

Goede kwaliteit van de EEG - registratie.

De slaap toont :

- Een normale inslaaptijd (LAP persistant sleep = 00:07:49) , een normale slaapefficiëntie (93,7 %) en een normale slaapduur (TST = 08:35:00).

- Beeld van onderbroken slaap!

- Slaaparchitectuur : er is een gebrek aan SWS en REM slaap met een verkorte REM latentie (00:59:30) .

- Er is een significante slaapfragmentatie (MAI = 20,4/uur).

Huidige mediactie:

- Nestrolan 100mg

Patient snurkt.

Er zijn obstructieve a-/hypopneus (AHI= 12,7 /h), gepaard gaande met snurken, arousals en een significante weerslag op de zuurstofsaturatie (min O2 sat 90 %)/ totaal minuten onder <90% = 00:00:00)

Er zijn frequente beenbewegingen suggestief voor een PLMS (Periodic Limb Movement Syndrome), in tweede helft van de nacht.

EKG: brady/tachy secundair aan respiratoire gebeurtenissen.

Diagnose en besluit

Aspecifiek beeld van dyssomnie type doorslaapstoornis.

Beeld van gestoorde diepe en REM slaapopbouw.

Beeld van een licht hoofdzakelijk REM gebonden OSAS (obstructief slaap apneu syndroom) (AHI = 12.7/uur en MAI = 20.4/uur).

Beeld van PLMS (Periodic Limb Movement Syndrome)

R/

- Hygiënische maatregelen (vermageren, inname van alcohol en benzodiazepines voor het slapengaan vermijden, slapen in ruglig vermijden)

- KNO onderzoek in kader van licht OSAS

- Titratenacht plannen

- nCPAP therapie starten.

- In verband met dyssomnie : te behandelen in functie van kliniek

- In verband met beenbewegingen : te behandelen in functie van de kliniek.

Dr. S. De Weerd
Pneumoloog - Somnoloog